

- ✓ E. L'articulation tibio-peronière est bien enfilée
5. Dans une radiographie de profil de la cheville :
- A. Le patient est debout
 - ✗ B. Le profil est externe ou péronier
 - C. La jambe est en flexion
 - ✓ D. Le pied est à 90° avec la jambe
 - ✗ E. Le rayon directeur est vertical
6. Dans la Radiographie du rachis cervical de profil :
- ✓ A. Le patient peut être assis ou debout
 - B. Le rayon directeur est centré sur C6
 - C. La tête est en légère inflexion
 - ✗ D. On doit voir de C1 à C7
 - E. Le profil droit est le seul profil accepté
7. Dans les radiographies obliques du rachis cervical :
- ✗ A. Le patient peut être assis ou debout
 - ✗ B. Le patient est oblique du même côté à explorer
 - C. Le rayon directeur est centré sur C6
 - ✓ D. On doit voir les trous de conjugaison bien ronds
 - ✗ E. Le rayon directeur est ascendant
8. La radiographie de profil de l'épaule de Lamy :
- ✗ A. Est appelée également le profil axial de la coiffe
 - ✓ B. Est une incidence postéro-antérieure
 - ✓ C. La position du patient est la même que pour le profil de NEER
 - D. Le rayon directeur est vertical
 - ✗ E. L'omoplate doit être vue dans sa totalité
9. Le profil de BLOOM et OBATA :
- A. Est un profil axillaire
 - B. Le rayon directeur est centré sur le milieu de l'épaule
 - C. L'omoplate est vue de face
 - D. La glène est médiane
 - E. L'acromion est dégagé en arrière
10. Dans le profil du cavum :
- A. Le rayon directeur est placé à 2cm en avant du conduit auditif externe
 - B. Le rayon directeur est centré sur le point tubaire
 - C. Le cliché est réalisé pendant l'expiration
 - D. Le cliché est réalisé en haute tension
 - E. Est considéré comme une incidence fondamentale pour l'étude du cavum

Concours de recrutement des infirmiers et techniciens de santé 1^{er} grade
Session 14 Décembre 2019

Cadre : technicien de santé

Option : Radiologie

Epreuve de spécialité

Durée : 2 heures

Coefficient : 3

Très important :

Le questionnaire comporte : 20 QCM, 4 Questions écrites

QCM

1. Dans l'incidence % obturateur :

- ☐ A. Le patient est debout
- ☒ B. Le patient soulève le coté à radiographier
- ☐ C. Le trou obturateur doit être bien rond sur le cliché
- ☐ D. Les branches ilio et ischio publiennes sont bien déroulées
- ☒ E. Le rayon directeur est centré en dedans de l'épine iliaque antéro supérieure

2. Dans une radiographie de la hanche de face :

- ☒ A. Le patient est en décubitus dorsal
- ☒ B. Le bassin est de face
- ☐ C. Le pied est en rotation externe
- ☒ D. Le rayon directeur est vertical
- ☐ E. L'articulation doit être au milieu du film

3. Dans une radiographie du genou face :

- ☒ A. Le patient doit être assis
- ☐ B. Les jambes sont en extension
- ☐ C. Le rayon directeur est ascendant de 5° environ
- ☐ D. On doit voir la corticale, la médullaire et les parties molles
- ☒ E. L'interligne fémoro-tibiale doit être visible

4. Dans une radiographie de la jambe de face :

- ☒ A. Le patient est en décubitus dorsal
- ☒ B. On doit voir les articulations sus et sous jacente
- ☐ C. Le rayon directeur est horizontal
- ☐ D. Le rayon directeur est centré au niveau de l'épine tibiale

- D. Elle nécessite une asepsie rigoureuse.
- E. Elle est réalisée sous guidage radioscopique.

17. Concernant la séquence STIR En IRM :

- A. Cette séquence est basée sur la technique d'inversion-récupération
- B. Cette séquence permet l'étude des mouvements de molécules d'eau.
- C. Il s'agit d'une séquence de suppression du signal de l'eau.
- D. Elle est utilisée pour aider au diagnostic de pathologie tumorale du rachis.
- E. Elle est souvent associée à la séquence T1 après injection.

18. Concernant les rayons X et la grossesse :

- ☒ A. L'exposition aux rayons X est formellement contre-indiquée dans la grossesse débutante.
- B. Les examens à rayons X seront réalisés en 2^e phase du cycle.
- C. L'exposition aux rayons X au 3^e trimestre augmente le risque de malformation fœtale.
- D. Devant une urgence extrême en 3^e trimestre, le recours à un examen à rayons X sera réalisé à défaut d'autre exploration répondant aux questions posées.
- ☒ E. Le fait de mettre une blouse plombée sur le pelvis permet une protection efficace et suffisante.

19. Concernant la tomodensitométrie double énergie :

- A. Réalise une acquisition simultanée à haut et à bas kilovoltage
- B. Permet de séparer les matériaux (iode, eau, calcium...)
- C. Permet de réduire de plus de moitié la dose d'iode injectée.
- D. Il faut absolument deux tubes à rayons X.
- E. Permet de réaliser une cartographie perfusionnelle des poumons dans les embolies pulmonaires

20. Parmi ces techniques, quelles sont celles d'imagerie vasculaire non invasive

- ☒ A. Échographie doppler vasculaire
- B. Artériographie
- C. Phlébographie
- ☒ D. Angio-IRM
- ☒ E. Angio-TDM.

Questions écrites

1. Techniques et critères de réussite des incidences de face de l'épaule et du profil de Lamy
2. Les contre-indications de l'IRM, du Gadolinium et les différents risques en salle d'IRM
3. Technique de réalisation d'un Uroscanner pour l'exploration d'une masse rénale
4. Technique de réalisation d'un Angioscanner thoracique pour une suspicion d'embolie pulmonaire.

11. En radiologie interventionnelle, le rôle du manipulateur est essentiel :

- A. Pour assister le radiologue
- B. Réaliser les acquisitions
- C. En s'occupant du patient
- ☒ D. Pour réaliser l'acte interventionnel
- E. Pour veiller à l'asepsie

12. En service de radiologie le manipulateur doit :

- A. Veiller à l'identovigilance.
- ☒ B. Vérifier l'enregistrement du patient sur le PACS et le RIS
- ☒ C. Réaliser une fiche de traçabilité pour le matériel et les produits utilisés.
- D. Expliquer au patient le résultat des examens radiologiques
- E. Expliquer aux accompagnants du patient les diagnostics évoqués par le radiologue.

13. En pratique de radiologie vasculaire :

- A. Le French (F) est l'unité de mesure des diamètres des guides
- B. L'Inch (1") est l'unité pour la mesure des diamètres des sondes
- C. Le Gauge (G) est utilisé pour mesurer le diamètre externe des aiguilles
- D. Le millimètre est utilisé pour tous le petit matériel
- E. Il existe différents types de sondes et de guides.

14. L'angioscanner thoracique pour embolie pulmonaire :

- A. Ne nécessite pas d'injection de produit de contraste.
- B. Le produit utilisé est le gadolinium.
- C. L'acquisition sera réalisée précocement (25 secondes environ après l'injection)
- ☒ D. Les clichés fournis au patient seront limités aux fenêtres médiastinales.
- E. L'apnée quand elle est possible n'est pas obligatoire.

15. L'angioscanner hépatique pour caractérisation d'un nodule du foie :

- ☒ A. Est un scanner réalisé pour avoir une cartographie de la vascularisation du foie.
- ☒ B. Est un scanner réalisé en deux temps, sans injection et après injection au temps artériel.
- C. Est un scanner réalisé au moins en trois temps.
- D. 60 à 80 secondes après injection correspondent au temps artériel.
- E. L'injecteur automatique n'est pas obligatoire

16. Concernant L'arthrographie :

- A. Elle correspond à une opacification artérielle par voie transcutanée.
- B. Elle correspond à une cartographie artérielle par angioscanner.
- C. Elle correspond à une opacification d'une cavité articulaire.